

03 - 03- Les infections cutanéomuqueuses au Virus ZonaVaricelle - Pr. Hocar

Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce cours intitulé les infections cutanées dues au virus zona varicelle et qui fera suite au cours des infections cutanées à herpes simplex virus, les deux cours étant inscrits dans la partie des dermatoses virales. Au terme de ce cours, l'étudiant doit savoir expliquer le cycle du virus zona varicelle et doit diagnostiquer la varicelle dans sa forme bini, la varicelle dans ses formes graves et traiter toutes les formes de varicelle. Et puis l'étudiant doit être capable de diagnostiquer un zona, de ses complications, traiter un zona et traiter les algiposes ostériens.

La varicelle et le zona sont dus au virus varicelle zona, un virus à ADN de la famille des herpès virides et de contamination strictement inter-humaine. La varicelle correspond à la primo-infection et le zona à une recurrence, une infection latente touchant les ganglions sensitifs s'étant établi après la primo-infection et peuvent être soumises à une réactivation. L'infection varicelle zona virus apporte une immunité durable et définitive.

L'immunité cellulaire joue un rôle majeur en contrôlant l'infection car la sévérité de la symptomatologie dépend de l'état immunitaire. Les infections ou varicelles zona virus sont généralement binines mais des complications graves sont possibles chez les sujets immunodéprimés mais également chez l'adulte immunocompétent. La thérapeutique antivirale et en particulier la ciclovir a transformé le pronostic de ces infections et la prophylaxie par un vaccin atténué et recommandé chez les sujets à risque.

Comment peut-on décrire le virus varicelle zona au VZV? D'une taille d'environ 200 nanomètres, le VZV révèle en microscopie électronique une morphologie comparable à celle des autres virus herpès. Le génome viral est constitué d'une molécule d'ADN bécaténaire entourée d'une capsidie écozydrique composée de 162 capsomères et d'une enveloppe composée d'une double couche lipidique où sont ancrées les glycoprotéines. Entre la nucleocapsidie et l'enveloppe se trouve une structure amorphe et fibreuse, le tigument, comportant des protéines virales exprimées au cours du cycle de réplication du VZV.

La séroprévalence du VZV dans la population générale est extrêmement élevée. L'infection touche les enfants dès l'âge de 5 ans. La séroprévalence chez l'adulte étant aux alentours de 98%.

C'est le plus contagieux des herpès viridés. Le VZV se transmet à partir des vesicules cutanées et par inhalation de gouttelettes de plaque. Il est également disséminé par flux d'air d'une pièce à l'autre.

Rappelons que l'homme infecté est le seul réservoir du virus et que la contagiosité commence 1 à 2 jours avant le début de l'éruption et se poursuit jusqu'à la phase de crustation. La durée

d'incubation de la maladie est de 14 jours. La transmission du varicelle zona virus à travers le placenta peut se faire tout au long de la grossesse et le risque de varicelle congénitale qui est de 2% avant la 24e semaine d'améliorée est nul au 3e trimestre du gestation.

Enfin, on peut parler de varicelle nosocomiale chez le personnel de santé avec une prévalence de 1,2 pour mille dans la source de contamination et le plus souvent un zona. Le zona touche 10 à 20% de la population et l'incidence augmente avec l'âge. Les facteurs de risque principaux sont liés à l'immunodépression, en particulier celle relative à l'âge, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les traitements immunosuppresseurs.

En effet, la réponse lymphocytaire à l'antigène VZV décline avec l'âge avec le développement des lymphomes et les traitements immunosuppresseurs. La survenue d'un zona chez un patient HIV positif est prédictive d'un risque évolutif accru de la maladie. Enfin, la dissémination clinique des vésicules dehors du dermatome primaire est le signe d'une morbidité accrue chez le patient immunodéprimé.

La varicelle est la plus contagieuse des maladies irruptives. Après contamination respiratoire, la durée de la période d'incubation est de 14 jours, puis par dissémination hématogène du VZV, il atteint la peau et les miqueuses qui constituent les organes cibles. Il se réplique dans les kératinocytes dont il provoque la ballonisation.

C'est l'effet qu'on appelle l'effet cétopathique caractéristique des herpès véridés qui est responsable de la formation des vésicules intraépidermiques typiques de la varicelle. Les anticorps apparaissent au cinquième jour et sont à leur maximum au vingtième jour. Ce sont cependant la réponse immune cellulaire et la production de l'interféron qui limitent l'infection.

En cas de déficit du système immunitaire, le VZV peut être responsable de formes graves avec une atteinte pulmonaire, hépatique et du système nerveux central. Il faut noter que la varicelle est une maladie immunisante mais malgré la persistance des anticorps pendant plusieurs années, le VZV reste à l'état latent dans les ganglions sensitifs des nerfs crâniens et rachidiens. Notons que le zona est une recurrence localisée par rupture de l'état de latence virale due à des modifications de la pathogénicité du virus et ou de l'immunité cellulaire.

Le vieillissement du système immunitaire explique la plus grande fréquence du zona chez le sujet âgé et le faible pouvoir immunisant des varicelles survenant unitéaux aussi les petits nourrissons encore protégés par les anticorps maternels explique la survenue du zona chez l'enfant. En général, le zona ne survient qu'une fois dans la vie. Un zona peut être contaminant et donner une varicelle On arrive maintenant au diagnostic clinique et la première forme d'infection au VZV c'est la varicelle.

D'abord la forme typique binine de l'enfant. Il touche l'enfant de 2 à 12 ans dans 90% des cas avec un maximum de fréquences entre 5 et 9 ans. Elle survient par petite épidémie saisonnière à la fin de l'hiver et au début du printemps.

Après une incubation de 14 jours, en moyenne entre 10 et 21 jours, silencieuse, il y a la phase d'invasion qui est courte de 24 heures caractérisée par un syndrome prodromique frile avec malaise et des signes généraux. Les signes ne sont plus marqués chez l'adulte. L'éruption est caractéristique.

Il s'agit de macules rosées vite recouvertes de vésicules en gouttes de rosée qui passent par une embudication puis une crustation. Comme vous pouvez le voir sur cette photo qui représente un enfant âgé de 2 ans et demi qui est présente, c'est une éruption faite de vésicules embiliquées sur le menton mais aussi des macules érythémateuses éparpillées sur le visage dans le cadre d'une varicelle. Une autre photo qui illustre un enfant qui présente une varicelle.

On voit bien ce sont des lésions ulcérées par endroits microtiques entourées d'un érythème qui signale la surinfection des lésions de varicelle par une bactérie, généralement un streptococque. Là, une autre photo pour vous montrer les atteintes miqueuses qu'on peut rencontrer lors d'une varicelle. Donc, comme on peut voir, c'est des érosions buccales qui sont arrondies de quelques millimètres de diamètre, bien séparées les unes des autres.

J'ai un monsieur qui a présenté une varicelle. Cette photo montre un adulte jeune atteint de varicelles profuses et qui a des vésicules hémorragiques. C'est un patient qui est connu HIV et dans les formes de l'immunodéprimé, on peut avoir des vésicules hémorragiques et profuses avec des lésions.

Donc, il faut y penser quand on voit une varicelle avec des lésions profuses. Pensez à chercher et à diagnostiquer une immunodépression. Les lésions poussées fibriles peuvent se succéder donnant au tableau dermatologique des éléments d'âge différents, l'évolution imbutine et la guérison obtenue en 15 jours.

La varicelle est une infection immunisante. Un deuxième épisode est peut-être vu dans le cadre d'une immunodépression. On arrive maintenant aux formes cliniques de la varicelle et on peut avoir des formes possysymptomatiques, ça veut dire possylésionnelles.

Donc, généralement, c'est le cas des enfants immunocompétents avec quelques lésions et des symptômes légers au niveau cutané, mais aussi au niveau général. On peut avoir aussi des formes compliquées et graves de la varicelle. Elles sont exceptionnelles chez l'enfant.

Ces formes graves compliquées sont essentiellement liées au terrain. La surinfection cutanée bactérienne peut être prévenue par une antipsy des lésions cutanées. Les dermo-hypodermite aiguë post-varicelle ne sont pas rares.

On peut avoir des placards isolés des membres du thorax avec de la fièvre parfois prolongée. L'évolution sous antibiothérapie est favorable. On peut avoir aussi des éruptions et séuronicrotiques ou hémorragiques souvent profuses, sont principalement observées chez

l'adulte.

Chez l'immunodéprimé, on peut avoir des lésions extensives, hémorragiques ou nécrotiques avec des signes généraux importants et des atteintes viscérales, notamment atteintes neurologiques, hépatiques et pulmonaires. Toujours dans les aspects cliniques différents de la varicelle, on arrive aux formes cliniques compliquées. Elles sont favorisées par l'âge, par exemple un nourrisson âgé de moins d'un an, les adultes, généralement ils font des formes compliquées, la femme enceinte, la présence d'épidémies familiales, la présence d'un terrain dermatologique sous-jacent comme des poussées d'eczéma préexistants, la présence d'une corticothérapie soit orale, soit locale et l'immunodépression.

On peut aussi assister à la présence de complications cutanées qui sont présentes en 40% des cas. Ce sont des surinfections bactériennes, d'éruptions et séronécrotiques, hémorragiques, profuses avec des signes cliniques graves. De même, le tabagisme qui est un facteur de risque favorisant la pneumopathie de la varicelle.

Il s'agit d'une pneumopathie interstitielle survenant un à six jours après l'éruption, se traduisant par une dyspnée, une toux avec des hémoptysies et parfois une détresse respiratoire aiguë. La radio pulmonaire montre des opacités micro et macronodulaires multiples. Elle est responsable de 30% des décès enregistrés au cours de la varicelle de l'adulte.

Les complications neurologiques observées au cours de la varicelle sont rares chez l'enfant. Il consiste surtout en une atteinte cérébelleuse réalisant un tableau d'ataxie aiguë pouvant ou non s'accompagner d'autres signes neurologiques et dont l'évolution est généralement favorable, régressive, sans séquelles. D'autres complications sont encore observées comme un purpurathrombopénique de bon pronostic, une hépatite biologique avec insuffisance hépatocellulaire, une atteinte rénale se forme de glomerulonephrite aiguë, un syndrome néphrotique oculaire, conjonctivite, uvéïte, schéatite, névrite optique, arthrite, myocardite et péricardite.

Toujours dans les formes cliniques de la varicelle, on arrive aux formes de l'immunodéprimé. Ce sont des formes graves et sont atypiques, ulcéro-hémorragiques, profuses, plus souvent compliquées. Donc on peut assister à une forme qu'on appelle la varicelle progressive ou maligne avec risque de dissémination viscérale, notamment hépatique, pulmonaire et neurologique.

Les enfants sous traitement immunosuppresseur peuvent faire ce genre de formes graves, surtout les enfants suivis pour des cancers, des lymphomes, le cœliac, greffes et d'organes. Donc de l'intérêt de les prévenir du contact, la vaccination en période de rémission par un vaccin vivant atténué, surtout la frappe personnelle soignant. Les immunoglobulines spécifiques anti-varicelle, c'est un traitement efficace en intramusculaire si précoce et dans les 48 heures, 72 heures en cas de contact.

Mais aussi, on peut proposer la cyclovire 5 à 7 jours après le contage en traitement préventif systématique dès la greffe pendant 2 à 3 mois, en intraveineuse pendant 3 semaines, puis relé par voie orale pour prévenir ces formes graves en cas d'immunodépression d'origine iatrogène. La grossesse est une situation qui peut s'associer à une varicelle. La prévalence de la varicelle au cours de la grossesse est de 5 à 7 pour 10 000 grossesses.

Chez la femme enceinte, le risque de plomopathie existe comme chez tout adulte et le danger essentiel est le risque de transmission à l'enfant qui est de 5% des femmes enceintes. Donc, ces femmes enceintes ne sont pas immunisées contre le VZV. Elles exposent l'enfant au risque de varicelle congénitale avant la 24e semaine d'aménor.

Après la 25e semaine, le risque de la survenue d'un zona dans l'enfance est très plausible. Lorsque la contamination fœtale a lieu juste avant et après l'accouchement, le risque de varicelle néonatale est lié à l'absence de transmission des anticorps maternels et donc la gravité du tableau clinique impose un traitement antiviral précoce. Comment faire le diagnostic d'une varicelle ? Généralement, le diagnostic clinique est facile.

La facilité du diagnostic clinique rend le diagnostic biologique rarement utile. En cas de doute dans les formes graves ou dans le cadre de protocoles de recherche, on peut réaliser des prélèvements du liquide des vésicules, méenculture et isolement du VZV ou mettre en évidence l'effet cétopathogène du virus avec des cellules ballonisantes intraépidermiques ou rechercher le virus par immunofluorescence ou immunohistochimie avec des anticorps monoclonaux. Quant à la PCR, il est réservé aux formes compliquées, en particulier chez l'immunodéprimé.

Pour différencier la varicelle avec les autres dermatoses, surtout le prurigostrophilus, donc c'est une dermatose prurigineuse mais rarement fibrile, donc il n'y a pas l'héprodrome, il n'y a pas la fièvre. L'impetigus, c'est une dermatose aussi prurigineuse mais il n'y a pas de vésicule embyliquée. Et l'eczéma de contact, c'est une dermatose prurigineuse et vésiculeuse mais il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas le contexte épidémique de varicelle ou de cas similaires.

Cette diapo résume les complications de la varicelle, on les a vues dans les formes compliquées. Donc qu'est-ce qu'il faut craindre quand on est face à un patient qui présente une varicelle? D'abord les surinfections bactériennes, notamment staphylococcique et streptococcique, les complications pulmonaires, notamment la pneumopathie varicelleuse qui se voit chez l'adulte mais aussi l'immunodéprimé, l'atteinte neurologique, le syndrome de Re, qui atteint surtout l'enfant et favorisé par la prise de l'aspirine et les autres complications exceptionnelles comme le purpurafulminance, les hépatites, les myocardites. Nous arrivons maintenant à la prise en charge d'une varicelle et on commence par le traitement.

Une varicelle bénigne de l'enfant se contente d'un traitement local et symptomatique, ça veut dire l'usage d'antiseptiques, d'antihistaminiques, du paracétamol et d'antibiotiques en cas de surinfection. L'éviction scolaire est prescrite jusqu'à la guérison clinique. Les antiviraux ne sont

pas indiqués en l'absence de complications chez l'enfant.

Nous arrivons maintenant au traitement spécifique et il fait appel à l'acyclovir, qui est un virus statique n'agissant que sur la population virale en répllication active. Les indications des antiviraux au cours de la varicelle ont fait l'objet d'une conférence de consensus en 1998. Selon l'autorisation de mise sur le marché, l'acyclovir, par voie intraveineuse, est indiqué dans les formes compliquées de la varicelle.

Chez l'immunodéprimé, chez l'adulte dénutri, on peut recommander au rail même la prescription d'acyclovir devant une forme grave chez le nourissant de moins d'un an ou du nouveau né si la mère a eu une varicelle au moment de l'accouchement. Même recommandation chez la femme enceinte au moment de l'accouchement ou dans les formes graves. La prévention de la varicelle passe par les immunoglobulines spécifiques anti-VZV et le vaccin vivant atténué.

Les immunoglobulines spécifiques sont prescrites à la dose de 125 unités par 10 kg de poids en cas de contagé chez un immunodéprimé VZV séronégatif ou chez une femme enceinte également séronégative. On propose également des immunoglobulines chez le nouveau né dont la mère a eu une varicelle une semaine avant l'accouchement. Comme vous pouvez le voir, ce diapos montre le tableau qui résume les indications des antiviraux en cas d'infection à varicelle zona virus.

Quand on est devant une varicelle, chez l'immunocompétent, pas d'indication dans les formes non compliquées. Si on a une forme compliquée, on peut proposer l'acyclovir en intraveineux pendant 8 à 10 jours à la dose de 10 mg par kg par 8 heures. Et chez l'enfant, 500 mg par mètre carré toutes les 8 heures.

Ça, c'est dans le cadre d'une AMM. Chez l'immunodéprimé, selon l'AMM, l'adulte, on peut proposer 10 mg par kg par 8 heures. Et l'enfant ou l'adulte du Nutri, on peut proposer l'acyclovir à la dose de 500 mg par mètre carré par 8 heures dans la durée du traitement et de 8 à 10 jours.

Pour les cas particuliers, on a des recommandations hors AMM. Notamment, en cas de varicelle du nouveau-né, si la mère a eu une varicelle 10 jours avant et 2 jours après l'accouchement, on peut proposer le traitement à la dose de 20 mg par kg par 8 heures. En cas de forme grave dans l'âge de l'enfant est inférieur à 1 an, et la varicelle de la femme enceinte lors de l'accouchement ou lors de forme grave de la femme enceinte, on peut proposer aussi l'acyclovir, mais hors AMM.

La prévention de la varicelle passe par des immunoglobulines spécifiques anti-VZV et le vaccin vivant atténué de souche OCA. Les immunoglobulines spécifiques varicelles zona virus sont prescrites à la dose de 125 unités par 10 kg de poids en cas de contagé chez un immunodéprimé VZV séronégatif ou chez une femme enceinte également séronégative. On propose également les immunoglobulines chez le nouveau-né dont la mère a une varicelle une semaine avant l'accouchement.

Côté vaccins, on a deux vaccins à virus vivant atténué sont disponibles, Varivax et Varilerix. Leur efficacité varie de 65 à 100%. On a 96% séroconversion et diminution de l'incidence du zona.

C'est des vaccins qui sont bien tolérés, quelques effets secondaires comme un rage, fièvre, réaction au site d'injection. Et ils ont des indications dans le cadre du Naïmé. C'est la prévention de l'infection varicelle zona virus chez les enfants immunodéprimés, hors HIV, avant une immunosuppression intense et lors d'une fenêtre thérapeutique.

Aussi, l'indication chez la fratrie et le personnel soignant. Après avoir vu les manifestations de la primo-infection du virus zona varicelle, nous allons voir maintenant les manifestations de la réactivation de ce virus qui est le zona. Le zona est défini comme une ganglion radiculonevrite postérieure aiguë due à une réactivation du virus zona varicelle restée latent dans les neurones du ganglion nerveux.

Il est aussi dû à une nouvelle exposition au virus. Les ganglions thoraciques et les ganglions trigéminalés sont les sites les plus fréquemment touchés. Il faut noter que la gravité, la fréquence et la sévérité du zona augmentent avec l'âge et l'immunodépression.

Il faut noter que la survenue d'un zona chez un adulte jeune doit faire proposer une sérologie VIH. Sur le plan clinique, la forme typique du zona, si on prend un type de description, le zona intercostal, qui représente 50% des cas, il touche le métamère D5 à D12. L'éruption est précédée de 1 à 3 jours, parfois une semaine, dans 90% des cas, de douleurs hémitoraciques associées à un syndrome prodromique et des adénopathies homolatérales axillaires.

Ce tableau conduit souvent à une errance diagnostique avant que n'apparaisse l'éruption, qui est très caractéristique. Et les métamériques, unilatérales, ce sont d'abord des éléments maquilopapuleux, érythémateux, souvent groupés en îlots antérieurs, latéraux thoraciques et latéraux dorsaux, se couvrant de vésicules à liquide clair, groupés en bouquets, confluant parfois en bulles polycycliques. L'éruption s'étend progressivement sur tout le métamère de l'hémitoraxe.

Après 2 à 3 jours, les vésicules se fêtrissent, puis se dessèchent en croûte, qui tombe une dizaine de jours plus tard. Il peut persister des cicatrices atrophiques ou hypochromiques. Cette topographie radiculaire unilatérale est très évocatrice et peut apporter un argument décisif au diagnostic lorsque les lésions vésiculeuses sont discrètes, absentes ou éphémères, ou dans les formes érythémateuses pures, ou encore celles observées au stade croûteux.

À côté de la symptomatologie cutanée, il y a des signes neurologiques ou un syndrome neurologique, qui consistent essentiellement en des algies pénibles et des douleurs lancinantes associées à des îlots d'hypoesthésie et des troubles sympathiques. La symptomatologie générale est discrète avec un léger fibricule. Le plus souvent, l'évolution est favorable avec régression progressive des douleurs et de l'éruption en 2 à 3 semaines.

Les algies persistantes résiduelles sont l'apanage du sujet âgé. Sur le plan évolutif, le zona guérit en 2 à 4 semaines au prix de cicatrices atrophiques, acromiques ou pigmentées. Des fois, elle peut guérir sans séquelles.

On peut avoir des douleurs qui peuvent disparaître, mais peuvent persister longtemps et de façon intense, surtout chez la population âgée. Le zona confère l'immunité et un second épisode est très rare. Cette photo illustre un zona thoracique chez une jeune patiente.

On voit bien que l'éruption s'arrête sur la ligne médiane et il est en hémicyclures, donc ça s'étend sur tout le métamère vers la partie antérolatérale et la partie postérieure du corps. Le type d'éruption est fait par des macules erythémateuses surmontées de vésicules et de bulles. Parfois, on peut trouver aussi des érosions post-vésiculo-bulleuses.

Cette photo montre un zona ophthalmique. On le voit bien, ce forme d'une plaque erythémateuse surmontée de vésicules, de croûtes hémorragiques et croûtes jaunâtres qui s'arrêtent sur la moitié du front, la partie suprasourcilaire et la paupière supérieure. Il faut noter que, si dû à une réactivation du VZV à partir du ganglion de Gasser, le syndrome neurologique et l'éruption cutanée se manifestent dans le territoire du nerf ophthalmique, branche du très jumeau, le nerf 5, et le plus souvent l'une de ces branches, soit la branche frontale qui prend l'hémifront, la partie interne de la paupière supérieure, la branche lacrymale temporomalaire, partie externe de la paupière supérieure, aux branches nasales qui innervent l'ongle interne de l'œil, la conjonctive, la racine du nez, la cloison nasale qui peut donner un choryza avec une anesthésie cornéenne.

Une autre localisation du zona sur la partie antérolatérale de l'abdomen, ça peut simuler une douleur abdominale qui peut conduire à avoir un chirurgien si on n'avait pas encore l'éruption cutanée qui va confirmer et vraiment être l'argument diagnostique décisif. Sur le plan clinique, on peut voir ici des plaques erythémateuses, mais quelques lésions vésiculeuses et quelques lésions bulleuses étendant sur tout le métamère. Une autre forme du zona qu'on peut avoir, c'est un zona hémorragique et purpurique, on voit très bien la coalescence des macules qui va donner naissance à des plaques étendues qui débordent sur le métamère atteint chez un patient avec ce zona lombaire.

Là, c'est le diapos pour vous rappeler la répartition des métamères selon les racines nerveuses des téguments. On peut voir la répartition au niveau facial, on a le 5-1, 5-2, 5-3 et puis la deuxième branche cervicale et puis la quatrième branche cervicale, la troisième sur le cou. Et on a les autres branches nerveuses selon le territoire innervé.

Plusieurs formes cliniques peuvent se voir avec le zona. On peut avoir des éruptions vésiculeuses, bulleuses, hémorragiques, c'est-à-dire le liquide de la bulle et du son. Et on peut avoir aussi une éruption nécrotique faite de plaques de nécrose étendues sur un métamère.

Donc, la nécrose est vraiment une croûte noirâtre sur le métamère atteint. Toujours dans les

formes cliniques et là, les formes topographiques, il faut savoir que le zona peut survenir dans n'importe quel territoire. La réactivation du varicelle zona virus a lieu le plus souvent dans les ganglions nerveux rachidiens.

Le zona intercostal aux dorsaux lombaires est le plus fréquent, donc 50% des cas, mais il peut atteindre tout le territoire sensitif cutané. Toujours dans les formes topographiques, la localisation de ganglions nerveux crâniens est moins fréquente, avec surtout l'atteinte du ganglion de Gasser responsable d'une éruption dans les divers territoires du trigéme. Dans le zona ophtalmique, c'est le nerf ophtalmique de Willis qui est intéressé.

Il y a risque d'atteinte oculaire s'il existe une éruption nasale et de la cloison, témoignant de l'atteinte du rameau nasal interne. S'il s'agit du ganglion géniculé, c'est le nerf de Vissberg, branche sensitive du facial, dont le territoire cutané se réduit à la zone de Ramsay Hunt, qui contient le conduit auditif externe et la conque de l'oreille, qui est intéressé. A l'éruption discrète dans ce territoire s'associe une vive otalgie, une adénopathie prétragienne, une anesthésie des deux tiers antérieurs de l'hémelangue et parfois une paralysie faciale et des troubles cochlio-vestibulaires.

Sur cette diapo, on peut voir une fiche récapitulative des formes morphologiques et topographiques du zona. D'abord, on peut distinguer les zones hémorragiques, nécrotiques, érythémateuses pures, bilatérales, généralisées. Et puis, on peut avoir des formes rachidiennes, des formes céphaliques, zones faciales et des zones du nerf 10.

On est toujours dans les formes cliniques du zona. Maintenant, on va voir les formes cliniques selon le terrain. Quand un zona survient chez une femme enceinte, il n'y a pas de risque d'atteinte fœtale.

Cependant, quand ça survient chez un sujet âgé, le risque est important d'atteinte de douleurs résiduelles intenses, d'atteintes et de complications oculaires lorsqu'il s'agit d'un zona ophtalmique. Et aussi, quand il s'agit des algéoses ostéïennes, elles sont souvent associées à une hypoesthésie du territoire atteint. Et souvent, c'est des douleurs neuropathiques de désafférentation distinctes des douleurs de la phase initiale.

Leur incidence augmente avec l'âge, 50% des cas à 50 ans, 70% des cas au-delà de 70 ans. Ces douleurs non-signifiantes à type de brûlure qui peuvent durer des années retentissent sévèrement sur la qualité de vie des patients. Et lorsqu'un zona survient sur un terrain d'immunodépression, notamment un terrain chez un patient qui a l'HIV ou un terrain de traitement immunosuppresseur, l'éruption prend un aspect hystéro-hémorragique nécrotique.

Exceptionnellement, le zona est bilatéral ou touche de façon étagée plusieurs métamères. Le zona généralisé, appelé parfois improprement zona varicelle, est caractérisé par une éruption zoniforme dans un métamère, suivie de l'apparition de vésicules varicilliformes bien séparées les unes des autres et disséminées sur tout le corps, en dehors du dermatome initialement atteint.

Dans ces formes graves surviennent parfois des complications viscérales, pulmonaires, hépatiques et encéphaliques.

Les complications qu'on peut redouter après un zona, c'est souvent des séquelles algiques. Donc, c'est des algies post-diostériennes. Elles durent au-delà de un mois après l'épisode aigu.

La douleur peut être continue ou paroxystique. Elles sont d'autant plus fréquentes que le sujet est âgé. On arrive maintenant au diagnostic.

Comme on l'a noté, le diagnostic est essentiellement clinique par une éruption faite de vésicules sur un métamère cutané, caractère très caractéristique du zona. En cas de doute, on a recours à des examens paracliniques et le diagnostic biologique n'est habituellement pas nécessaire car le diagnostic clinique est facile. En cas de doute, on peut réaliser un prélèvement du liquide de vésicule pour rechercher le VZV par immunofluorescence ou par culture.

On peut recourir à la PCR qui est une méthode rapide, spécifique et très sensible permettant de détecter de très faibles quantités d'ADN virale dans le liquide de vésicule et dans les cellules mononucléaires du sang périphérique en période de vémie. Toutes ces techniques sont réservées à des labos spécialisés, en général hospitaliers. Ces examens sont essentiellement réservés aux formes atypiques et lorsque le terrain nécessite un diagnostic de certitude, les patients HIV, les femmes enceintes, les autres examens comme le cétiagnostic, les biopsies, les sérologies n'ont pas d'intérêt en pratique.

Nous arrivons maintenant à la partie de la prise en charge. Le traitement du zona. D'abord, le traitement local est le même que pour la varicelle.

Le traitement antiviral par aciclovir, balaciclovir ou panpsiclovir doit débuter dans les 48 heures à 72 heures après le début de l'éruption. L'indication à elle-même retient chez l'immunocompétent le zona ophtalmique quel que soit l'âge et les zones toutes localisations confondues chez les sujets de plus de 50 ans. On arrive aux indications au traitement antiviral, par voie orale ou par voie parentérale.

Tous sujets immunocompétents de moins de 50 ans atteints d'un zona non ophtalmique d'intensité modérée, il n'y a pas d'indication à mettre un traitement antiviral par voie générale. L'éviction des collectivités n'est pas nécessaire en matière d'un zona. Pour les autres indications, le traitement doit être mis en route avant la 72e heure de la phase éruptive.

Chez les sujets immunocompétents avec un zona ophtalmique, quel qu'il soit leur âge, en prévention des complications oculaires, il faut mettre en route de la valacyclovir peros comme le valex, 3 g par jour pendant 7 jours, ou la cyclovir 800 mg, 5 fois par jour pendant 7 jours, ou la fancyclovir 500 mg, 3 fois par jour pendant 7 jours. Toujours dans les indications de traitement antiviral en matière de zona, il faut noter que quel qu'il soit la localisation, chez les plus de 50 ans en prévention des algépos ostériennes, il faut mettre en route un traitement par valacyclovir par

voie orale à la dose de 3 g par jour pendant 7 jours, ou la cyclovir 800 mg, 5 fois par jour pendant 7 jours, ou la fencyclovir 500 mg, 3 fois par jour pendant 7 jours. La forme orale est l'oravir, mais qui n'est pas disponible au Maroc.

Chez les sujets immunodéprimés, la cyclovir doit être mise en route par voie veineuse à la dose de 10 mg kilo toutes les 8 heures chez l'adulte et 500 mg par mètre carré toutes les 8 heures chez l'enfant pendant une durée minimale de 7 à 10 jours. Le traitement immunosépresseur y compris la corticothérapie ne doit pas être modifié. Là, c'est un tableau qui récapitule les indications des antiviraux dans le zona, en s'appuyant sur la conférence de consensus liée en 1998.

Donc, les indications du traitement par voie orale chez l'immunocompétent, c'est le zona oftalmique, c'est la cyclovir à la dose de 800 mg, 5 fois par jour pendant 7 jours, la valacyclovir 3 g par jour pendant 7 jours, et la fonciclovir 500 mg 3 fois par jour pendant 7 jours. Zona toutes les localisations chez les sujets au-delà de 50 ans, c'est la valacyclovir et la fonciclovir. Quand il s'agit d'un patient immunodéprimé, tout zona sera traité par acyclovir intraveineux pendant 7 à 10 jours.

Chez l'adulte, la dose est de 10 mg par kilo toutes les 8 heures. Chez l'enfant ou l'adulte dinutri, on peut aller jusqu'à 500 mg par mètre carré toutes les 8 heures. Quelques cas particuliers, on peut recommander le traitement par valacyclovir 1 g 3 fois par jour et fonciclovir 500 mg 3 fois par jour pendant 7 jours chez les sujets âgés de moins de 50 ans et ces facteurs prédictionnels d'algie post-zostérienne persistante.

Il faut toujours démarrer le traitement dans les 48 à 72 heures de l'érection. Rappelons que la corticothérapie générale ne présente pas de bénéfices à long terme sur la prévention des algies post-zostériennes. Celles-ci seront traitées par des ontalgies classiques en réalité peu efficaces ou la carbamazepine, en particulier dans les algies trégiminées.

La gammapentine aurait un effet ontalgique et également sur la restauration du sommeil. Ce sont les antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline qui semblent constituer la meilleure indication à condition qu'ils soient prescrits précocement pour être efficaces. On réserve les opiacés par voie orale à dose adaptée en cas de douleur persistante.

Enfin, on a proposé l'électrostimulation et la capsaïcine dont les effets thérapeutiques sont en réalité anecdotiques. Sur le plan préventif, un vaccin est actuellement disponible. Le Zostavax de Merck est prescrit chez les patients au-delà de 60 ans et réduit l'incidence du zona de 51% et l'incidence des douleurs post-zostériennes de 66%.

Une photo qui montre un zona lombaire chez une jeune patiente suivie pour une leucémie lymphoïde chronique sous traitement immunosuppresseur par chimiothérapie et qui présente ce zona lombaire avec des lésions erythémateuses vésiculeuses qui s'étendent sur un dermatome

du territoire lombaire. Un jeune patient qui se présente pour cette éruption métamérique avec des lésions érythémateuses vésiculeuses, ibullues. C'est un patient âgé de 20 ans et c'était les circonstances de découverte de son HIV.

On a examiné le patient, on a retenu le zona cervical et on a demandé la sérologie HIV qui est revenue positive. En conclusion, les messages à retenir après ce cours, c'est que la varicelle et le zona sont dus au même virus, le VZV. La varicelle correspond à la primo-infection alors que le zona a une recurrence localisée.

Pour noter, la varicelle est une maladie très contagieuse, très fréquente et habituellement bénigne dans l'enfance et ne nécessite dans ce cas que des soins locaux antiseptiques et pas de traitement antiviral systémique. Les varicelles de l'adulte, surtout après 50 ans, peuvent se compliquer de pneumopathie varicelleuse sévère pour laquelle le tabagisme constitue un facteur de risque. La varicelle est grave chez les immunodéprimés et nécessite un traitement antiviral systématique.

La survenue d'une varicelle chez la femme enceinte comporte pour l'enfant avant la 20^e semaine un risque de phétopathie varicelleuse sévère et dans les jours précédents ou suivants l'accouchement un risque de varicelle néonatale très grave. Concernant le zona, les messages à retenir c'est que le zona est plus fréquent et plus grave chez les sujets âgés. Les algéposes ostéïennes sévères sont très fréquentes après 50 ans et altèrent la qualité de vie.

Le zona ophtalmique avec ses complications oculaires graves se rencontre plus souvent à cet âge. Le zona du sujet de plus de 50 ans et le zona ophtalmique, quel que soit l'âge, nécessite un traitement antiviral précoce pour prévenir les algéposes ostéïennes. Les douleurs aiguës associées au zona sont fréquentes et nécessitent un traitement allant des antalgiques de classe 2 à la morphine.

Au stade de douleurs post-ostéïennes, on utilise des antidépresseurs type amitriptyline et ou de la carbamazépine ou la gabapentine. La survenue d'un zona chez un adulte jeune doit faire proposer une sérologie actualisée.